

Übungsprogramm – Schulter

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

Akute Schmerzbehandlung

– Entlastung und Kühlung (RICE)

Ausgangsposition: Sitzen oder Rückenlage, der Arm in einer komfortablen Position (z. B. mit Kissen gestützt).

Bewegung: Kühlung mit Eispackung (in Tuch) auf der schmerzhaften Schulterregion für 10–15 Minuten. Bei Bedarf Armschlinge zur Entlastung.

Wofür: Reduziert akute Schwellung und Entzündungsreaktion im Schultergelenk oder Schleimbeutel.

Tipp: Arm nicht vollständig ruhigstellen – sanfte Pendelbewegungen (Codman) sind besser als komplette Immobilisierung.

– Pendelbewegung (Codman-Pendel)

Ausgangsposition: Stand, leicht vornübergebeugt, gesunder Arm stützt sich auf einem Stuhl ab, betroffener Arm hängt frei.

Bewegung: Den Arm locker pendeln lassen – vorwärts-rückwärts, dann seitlich, dann kleine Kreise. Der Arm hängt passiv, kein aktives Heben.

Wofür: Nutzt die Schwerkraft zur schmerfarmen Mobilisation des Schultergelenks – verhindert Kapselverengung.

Tipp: Der Arm muss wirklich passiv hängen – kein aktives Anspannen der Schultermuskulatur.

Codman-Pendel: 5–10 Minuten täglich, besonders in der Akutphase.

Mobilisationsübungen

– Schulterrotation mit Stock (Innen- und Außenrotation)

Ausgangsposition: Sitzen oder Stand, Stock (Besenstil, Handtuch) waagrecht mit beiden Händen gehalten.

Bewegung: Den Stock mit dem gesunden Arm schieben, um den betroffenen Arm passiv in Außenrotation zu drehen – und zurück in Innenrotation. Ellbogen bleibt am Körper.

Wofür: Stellt die Rotationsbeweglichkeit des Schultergelenks schrittweise wieder her – bei Frozen Shoulder essenziell.

Tipp: Nur bis zur Schmerzgrenze – kein Durchdrücken. Die Bewegung soll ein leichtes Ziehen, keinen Schmerz erzeugen.

– Schultergürtel-Kreisen

Ausgangsposition: Sitzen oder Stand, Arme hängen locker seitlich.

Bewegung: Schultern langsam nach vorne, oben, hinten und unten kreisen. Dann Richtung wechseln. Große, kontrollierte Kreise.

Wofür: Mobilisiert den gesamten Schultergürtel (Sternoklavikular- und Akromioklavikulargelenk) und löst Verspannungen.

Tipp: Langsam und bewusst ausführen – die Grenze des Bewegungsraums auskundschaften, nicht erzwingen.

2 Sätze à 15 Wiederholungen pro Richtung.

Stabilitätsübungen

– Außenrotation am Band (0° Abduktion)

Ausgangsposition: Stand, Theraband auf Bauchhöhe befestigt, Ellbogen 90° gebeugt und am Körper anliegend.

Bewegung: Den Unterarm langsam nach außen drehen, Ellbogen bleibt am Körper, kurz halten, kontrolliert zurück.

Wofür: Kräftigt die Außenrotatoren (M. infraspinatus, M. teres minor) – essenziell für die Rotatorenmanschettenbalance.

Tipp: Der Ellbogen darf nicht vom Körper wegwandern – ein kleines Handtuch zwischen Ellbogen und Körper klemmen hilft.

– Innenrotation am Band (0° Abduktion)

Ausgangsposition: Stand, Theraband auf Bauchhöhe befestigt (auf der gegenüberliegenden Seite), Ellbogen 90° gebeugt.

Bewegung: Den Unterarm langsam nach innen drehen, Ellbogen bleibt am Körper, kurz halten, kontrolliert zurück.

Wofür: Kräftigt den M. subscapularis – wichtigsten Innenrotator der Rotatorenmanschette.

Tipp: Außen- und Innenrotation immer im Verhältnis 2:1 trainieren (mehr Außenrotation).

3 Sätze à 15 Wiederholungen pro Seite.

Kraftübungen

– Schulterdrücken mit Theraband (overhead, einarmig)

Ausgangsposition: Sitzen oder Stand, Theraband unter dem Fuß, Arm auf Schulterhöhe gebeugt, Handfläche nach vorne.

Bewegung: Den Arm kontrolliert nach oben strecken, kurz halten, langsam zurück auf Schulterhöhe.

Wofür: Stärkt den Deltoideus und Supraspinatus – die Hauptheber der Schulter.

Tipp: Nur ausführen wenn das Heben über Kopf schmerzfrei möglich ist. Bei Schmerzen arc (schmerzhafter Bogen) vermeiden.

– Seitliches Armheben (Lateral Raise) – leicht

Ausgangsposition: Stand, leichte Hanteln oder Theraband, Arm hängt seitlich.

Bewegung: Den Arm gestreckt seitlich bis auf Schulterhöhe heben (90°), kurz halten, langsam absenken. Daumen zeigt leicht nach oben.

Wofür: Stärkt den mittleren Deltoideus – wichtig für die Schulterbreite und Alltagsbewegungen seitlich.

Tipp: Sehr leichtes Gewicht beginnen. Den Arm nicht über Schulterhöhe heben – erhöhter Kompressionsdruck.

– Einarmiges Rudern (Bend-over Row)

Ausgangsposition: Stand, leicht vornübergeneigt, eine Hand stützt sich auf einem Stuhl ab, andere Hand hält Hantel oder Band.

Bewegung: Den Arm nach hinten ziehen, Ellbogen nach oben, Schulterblatt zusammenziehen. Kurz halten, kontrolliert absenken.

Wofür: Stärkt die Schulterblattraktoren und hintere Schultermuskulatur – Gegenspieler zur häufig überlasteten Außenseite.

Tipp: Oberkörper bleibt parallel zum Boden – keine Körperrotation beim Zug.

3 Sätze à 10–12 Wiederholungen. Pause: 60–90 Sekunden.

Allgemeine Hinweise

- Übungen 3–4 × pro Woche ausführen.
- Schmerzhafter Bogen (painful arc, ca. 60–120°): diese Zone langsam und kontrolliert passieren.
- Überkopfarbeiten und Schlafen auf der betroffenen Seite anfangs vermeiden.
- Außenrotations-Übungen sind die wichtigsten – nie vernachlässigen.
- Bei anhaltender Schwäche beim Armheben oder Schmerzen im Ruhezustand Arzt aufsuchen.